



YAZAN

Fzt. Ersin Saraç

Fizyoterapi & Rehabilitasyon Bilimsel Yazarı

Bilimsel inceleme: Doç. Dr. Senai Aksoy

Yayımlandı: 4 Mayıs 2026 · 8 dakikalık okuma

AA A- A A+ A

SONRA OKU

ZAMANSIZ YAŞAM · HAREKET

40 Sonrası Diz, Kalça ve Bel Ağrısı – Bedeni Dinleyerek Hareket Etmek

Kısa Özet

40 sonrasında diz, kalça ve bel ağrısını tek bir nedene bağlamak çoğu zaman yanıltıcıdır. Kas gücü, eklem yükü, uyku, kilo değişimi, denge ve günlük hareket alışkanlıkları aynı haritanın parçalarıdır. Bu yazı, ağrıyı susturmaya değil, bedenin verdiği sinyali okuyarak güvenli hareket alanı kurmaya odaklanır.

01

Ağrıya İsim Koymak: Tek Bir Nokta Değil, Bir Harita

Diz, kalça ya da bel ağrısı başladığında ilk soru genellikle "hangi hareket iyi gelir?" oluyor. Daha güvenli soru şudur: beden bu ağrıyla hangi yükü anlatmaya çalışıyor?

40 sonrası kas-iskelet ağrıları çoğu zaman tek bir dokudan çıkmaz. Eklem yüzeyi, kas gücü, tendon kapasitesi, omurga hareketliliği, uyku kalitesi ve günlük yüklenme biçimi aynı tabloya katkı verebilir (*iyi kanıt*). Bu nedenle ağrıyı tek egzersize bağlamak yerine, ağrının ne zaman arttığını ve ne zaman sakinleştiğini izlemek daha öğretici olur.

Bedeni dinleyerek ilerlemek pasif kalmak anlamına gelmez. Ağrının sesini duyup hareketi tamamen bırakmak ile ağrıyı yok sayıp yüklenmeye devam etmek iki uçtur. Klinik pratikte amaç, bu iki ucun arasında güvenli bir çalışma alanı bulmaktır.

02

40 Sonrasında Kas, Eklem ve Denge Neden Değişir?

Yaş alma yalnızca takvimle ilgili değildir; kas kuvveti, tendon esnekliği, eklem yükü ve denge sistemi de zaman içinde farklı çalışmaya başlar.

Yetişkinlik boyunca kas kütlesi ve kuvveti korunmadığında yavaş yavaş azalabilir. Menopoz geçişiyle birlikte vücut kompozisyonu, yağ dağılımı ve

toparlanma kapasitesi de deęişebilir (*iyi-güçlü kanıt*) . Kas gücü azaldığında eklemlerin taşıdığı yük daha belirgin hissedilir; diz ve kalça ağrısında bu mekanizma sık karşımıza çıkar.

Denge sistemi de yalnızca "denge tahtası" meselesi değildir. Görme, ayak tabanından gelen duyular, iç kulak, kalça çevresi kaslar ve gövde kontrolü birlikte çalışır. Dünya Sağlık Örgütü, yetişkinlerde düzenli fiziksel aktiviteye ek olarak güçlendirme ve yaşlı erişkinlerde denge içeren çok bileşenli hareketi önerir (*güçlü kanıt*) .

03

Bel, Diz ve Kalça Ağrısını Ayırmak Neden Önemli?

Aynı ağrı bölgesi farklı mekanizmalardan doğabilir. Haritayı doğru okumak, gereksiz korkuyu ve gereksiz yüklenmeyi azaltır.

Bel ağrısında çoğu tablo ciddi bir hastalık işareti olmadan, hareket kapasitesi ve yük toleransı üzerinden yönetilir. Kılavuzlar kronik bel ağrısında egzersiz, eğitim ve gerektiğinde çok disiplinli rehabilitasyon yaklaşımını ilk basamak seçenekler arasında görür (*güçlü kanıt*) . Bu cümle, herkesin aynı egzersizi yapacağı anlamına gelmez; kişinin ağrı davranışı ve işlev hedefi plana yön verir.

Diz ve kalça ağrısında eklem kireçlenmesi, tendon yüklenmesi, kas kuvveti kaybı ve hareket paternleri iç içe geçebilir. Diz ve kalça osteoartritinde egzersiz, kilo yönetimi ve eğitim güçlü biçimde önerilen çekirdek yaklaşımlardır (*güçlü kanıt*) . Ağrı varsa hareketi kesmek değil, hareketin dozunu ve biçimini kişiye göre düzenlemek gerekir.

04

Güvenli Hareket Haritası: Ağrıyı Susturmak Değil, Yanıtı Okumak

Hareket planı bir ceza ya da test değildir. Küçük adımların gücü, bedenin verdiği yanıtı izleyerek ilerlediğinde ortaya çıkar.

Güvenli hareket haritası üç soruyla başlar. Birincisi: ağrı hareket sırasında mı, hareketten saatler sonra mı artıyor? İkincisi: ağrı hareket alanını mı kısıtlıyor, yoksa yalnızca rahatsızlık olarak mı kalıyor? Üçüncüsü: ertesi gün belirgin sertlik, topallama veya güç kaybı var mı? Bu yanıtlar, hareketin dozunu ayarlama da çoğu zaman tek bir görüntüleme sonucundan daha kullanışlıdır.

Genel çerçevede yürüyüş, kas güçlendirme, eklem hareket açıklığı, denge ve nefesle birlikte gövde kontrolü aynı planın farklı parçalarıdır (*iyi kanıt*) . Fizyoterapist desteği, bu parçaları "şu programı yap" düzeyinden çıkarıp kişisel yüklenme haritasına dönüştürür. Amaç ağrısız bir beden vaadi değil; daha güvenli, daha anlaşılır ve sürdürülebilir hareket alanıdır.

05

Denge, Düşme Korkusu ve Günlük Yaşam

Denge çalışması yalnızca ileri yaş konusu değildir. 40 sonrasında güvenli hareket, ileriki yılların bağımsızlığını da etkiler.

Düşme riski yaşla birlikte artar; güç, denge ve çevresel düzenleme bu riski azaltmada birlikte düşünülür (*güçlü kanıt*) . Dengeyi yalnızca ayakta tek bacak durmak gibi görmek dar bir bakış olur. Sandalyeden kalkma, merdiven inme, kaldırım kenarında durma ve karanlıkta yön bulma gibi günlük hareketler de denge sistemini sınar.

Bu nedenle hareket planı yalnızca ağrılı bölgeye bakmamalıdır. Diz ağrısı olan bir kişide kalça çevresi kuvvet, ayak bileği hareketliliği ve gövde kontrolü de değerlendirilir. Bel ağrısı olan bir kişide kalça hareket açıklığı ve yürüyüş ritmi tabloyu etkileyebilir. Beden bölge bölge çalışır gibi görünür; işlev sırasında bütün olarak davranır.

06

Ne Zaman Fizyoterapi veya Hekim Desteği Gerekir?

Her ağrı alarm değildir. Yine de bazı sinyaller, beklemek yerine değerlendirme almanın daha doğru olduğunu gösterir.

Ağrı günlük yürüyüşü, merdiven inmeyi, uykuyu veya işe dönüşü belirgin kısıtlıyorsa fizyoterapi değerlendirmesi anlamlıdır. Üç aydan uzun süren, dalgalansa da tamamen yatışmayan veya tekrar eden ağrılarda hareket alışkanlığı, kuvvet, denge, eklem hareketliliği ve yüklenme düzeni birlikte incelenmelidir (*iyi kanıt*) .

Hekim değerlendirmesi özellikle travma, enfeksiyon bulgusu, açıklanamayan kilo kaybı, ilerleyen nörolojik belirti veya kanser öyküsü gibi durumlarda geciktirilmemelidir (*güçlü kanıt*) . Fizyoterapi bu haritanın hareket ve işlev tarafını kurar; tıbbi ayırıcı tanı gerektiğinde hekimle aynı masada düşünülür.



DİKKAT ÇEKMEK İSTEDİĞİMİZ

Hekiminize danışmanın anlamlı olduğu durumlar

Aşağıdaki belirtiler tek başına bir tanı anlamına gelmez; ama hekim değerlendirmesinde fayda görebileceğin durumlardır.

- Düşme, çarpma veya burkulma sonrası üzerine basamama ya da belirgin şekil bozukluğu
- Bacakta ilerleyen güç kaybı, uyuşma veya ayak bileğini kaldıramama
- İdrar veya dışkı kontrolünde yeni kayıp, kasık çevresinde uyuşma
- Ateş, gece terlemesi, açıklanamayan kilo kaybı veya genel durum bozukluğu ile birlikte ağrı
- Kanseri öyküsü olan kişide yeni başlayan ve dinlenmayla geçmeyen bel, kalça veya kemik ağrısı
- Gece uykudan uyandıran, pozisyonla rahatlamayan ve giderek artan ağrı

Bu liste tanı koymaz; beklemek yerine sağlık profesyoneliyle hızlı değerlendirme gerektirebilecek durumları hatırlatır.

07

Sıkça Sorulanlar

Ağrı varken hareket etmek zararlı mı?

Her ağrı zarar anlamına gelmez; ama her ağrı görmezden de gelinmez. Hafif ve hareket sonrası kısa sürede yatışan rahatsızlık çoğu zaman yüklenme ayarıyla yönetilebilir (*iyi kanıt*). Ağrı hareketle belirgin artıyor, ertesi gün işlevi bozuyor veya güç kaybı eşlik ediyorsa planın yeniden düzenlenmesi gerekir.

Bel, diz ve kalça ağrısında tek bir doğru egzersiz var mı?

Hayır. Kılavuzlar egzersizi güçlü biçimde destekler; ancak egzersizin türü kişinin ağrı davranışına, kuvvet düzeyine, denge durumuna ve günlük hedeflerine göre değişir (*güçlü kanıt*) . Bu yüzden iyi plan, tek hareket değil; kişinin yanıtına göre ayarlanan hareket haritasıdır.

Yürüyüş yeterli olur mu?

Yürüyüş iyi bir başlangıç olabilir; dolaşım, eklem beslenmesi ve genel dayanıklılığa katkı sağlar. Ancak kas gücü, denge ve eklem kontrolü için tek başına her zaman yeterli değildir. WHO yetişkinlerde aerobik aktiviteye ek olarak kas güçlendirmeyi de haftalık hareketin parçası olarak önerir (*güçlü kanıt*) .

Görüntüleme sonucumda kireçlenme veya fitik yazıyor; ağrımın nedeni bu mu?

Görüntüleme bulguları önemli bilgi verebilir, ancak tek başına ağrının tamamını açıklamayabilir. Klinik muayene, hareketle değişen ağrı, güç ve işlev değerlendirmesi birlikte yorumlanmalıdır (*iyi kanıt*) . Bazen raporda görünen bulgu uzun süredir vardır; yeni ağrıyı yaratan şey yüklenme düzenindeki değişim olabilir.

Fizyoterapiye ne zaman başlamalıyım?

Ağrı günlük yaşamı kısıtlıyorsa, tekrar ediyorsa veya üç ayı aşılıyorsa değerlendirme almak iyi bir adımdır. Amaç yalnızca ağrılı bölgeye müdahale etmek değil; hareket alışkanlığını, kuvveti, dengeyi ve güvenli yüklenmeyi birlikte düzenlemektir.

08

Kapanış

40 sonrası diz, kalça ve bel ağrısı bedenin "dur" dediği tek bir nokta değildir. Çoğu zaman beden, yüklenme biçimini yeniden düşünmeye çağırır. Bu çağrı panik gerektirmez; dikkat, düzen ve küçük adımlar gerektirir.

Bedeni dinleyerek ilerlemek, ağrıyı büyütmeden ama hareketten de vazgeçmeden yol bulmaktır. Hangi hareketin size uygun olduğunu, bedeninizin ertesi gün verdiği yanıt ve profesyonel değerlendirme birlikte belirler. Küçük bir adım bazen büyük bir programdan daha öğreticidir; çünkü sürdürülebilir olan hareket, zamanla güveni de geri çağırır.

+ İLGİLİ OKUMALAR

Sırada okunabilir

01

ZAMANSIZ YAŞAM

40 Yaşından Sonra Kemik Sağlığı – Koruyucu Rehber

02

ZAMANSIZ YAŞAM

Menopozda Kilo Artışı – Aynı Yaşamda Değişen Bedenle Sakin Bir Sohbet

03

BEDEN YAKİNLİK

Menopozda İdrar Kacırma Pelvik Taban

04

HORMONAL GECİS

Tarama Testleri

05

ZAMANSIZ YAŞAM

D Vitamini Rehberi

BİLİMSEL EDITÖR NOTU

Kanıt Düzeyi: (iyi-güçlü kanıt)

Bu yazı, fizyoterapi alanındaki hareket ve işlev değerlendirmesini kadın sağlığı bağlamına taşıyor. Tıbbi açıdan önemli olan nokta, ağrıyı ne küçümsemek ne de

her ağrıyı görüntüleme raporuna indirgemektir.

Klinik bağlam: 40 sonrası kadınlarda bel, diz ve kalça ağrısı kas gücü, eklem yükü, vücut kompozisyonu, uyku, hormonal geçiş ve günlük hareket alışkanlıklarıyla birlikte değerlendirilmelidir. Egzersiz ve eğitim; kronik bel ağrısı, diz-kalça osteoartriti ve düşme riskini azaltma alanlarında güçlü kılavuz desteğine sahiptir.

Sınır: Egzersiz önerileri kişisel muayene yerine geçmez. Ağrının yeri, yayılımı, nörolojik bulgu, travma öyküsü, kemik kırılabilirliği riski ve eşlik eden hastalıklar değerlendirmeyi değiştirir. Özellikle ilerleyen güç kaybı, idrar-dışkı kontrolünde yeni sorun, ateş, açıklanamayan kilo kaybı veya kanser öyküsü varsa tıbbi değerlendirme gecikmemelidir.

Pratik bütünleşim: Fizyoterapi, hareketin dozunu ve biçimini kişiye göre düzenleyen bir süreçtir; tek bir egzersiz reçetesinden ibaret değildir. Hekim ve fizyoterapist işbirliği, özellikle uzun süren ağrı, düşme riski, osteoporoz veya nörolojik belirti bulunan kişilerde kararın güvenli kurulmasına yardımcı olur.

— Doç. Dr. Senai Aksoy, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Estranova Bilimsel Editörü

Bu içerik genel bilgi amaçlıdır ve bireysel tıbbi değerlendirme yerine geçmez. Tanı, tedavi ve egzersiz planı için sağlık profesyoneline başvurunuz.

ESTRANOVA EDITORYAL SAĞLIK PLATFORMU

Perimenopoz, menopoz ve 40+ sağlık başlıklarında kanıta dayalı editoryal içerik platformu.

İçerik

Hormonal Geçiş

Zamansız Yaşam

Beden & Yakınlık

Zihin & Denge

Bilimsel Pencere

Hakkımızda

Manifesto

Platform Hakkında

Editöryal Politika

Editöryal İlkelerimiz

Künye

İletişim

Yasal

Tıbbi Sorumluluk Reddi

KVKK Aydınlatma Metni

Kullanım Koşulları

Site Yöneticisi: **Berna Aksoy** · Bilimsel Editör / Editöryal Danışman Hekim: **Doç. Dr. Senai Aksoy**

© 2026 ESTRANOVA. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

TIBBİ SORUMLULUK REDDİ

EDİTÖRYAL POLİTİKA

KVKK AYDINLATMA METNİ

KULLANIM KOŞULLARI

KÜNYE

İLETİŞİM